

18 - Mortalité maternelle - Pr. FAKHIR

On ne va plus discuter, c'était là. Rapidement, on va parler un petit peu de la mortalité maternelle, puisqu'on a déjà étudié cette complication qui peut être mortelle. Sachez qu'il y en a plusieurs, mais dans votre tête, il y a deux choses graves pour la femme enceinte.

Deux choses graves. La mortalité de l'homme. Non, ce n'est pas la fierté.

Un, prééclampsie. Hémorragie de la délivrance, prééclampsie. Et de la prééclampsie, toutes les autres complications vont venir de là.

D'accord? Et donc, tous nos efforts doivent converger vers la prévention de l'hémorragie de la délivrance et de la prééclampsie. Donc, la mortalité maternelle, dans notre pays, et dans pas mal d'autres pays en développement ou sous-développés, c'est un problème de la santé publique. Quand on dit problème de la santé publique, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème uniquement du médecin ou ce n'est pas un problème de diagnostic, mais c'est un problème de tout un contexte qui assemble beaucoup de choses économiques, éducationnelles, couverture sanitaire, géographie, tout ce que vous voulez.

D'accord? C'est ça, le problème de la santé publique. Alors, souvent, presque toujours, de cause évitable, presque toujours, il reste vraiment une toute petite proportion qui est non-évitable. Non-évitable, c'est-à-dire je n'ai pas de moyens de l'éviter.

C'est fatal. L'embolie amniotique, par exemple, c'est fatal. Mais je n'ai pas de moyens de la prévenir.

Je n'ai pas de moyens de traiter plutôt pour ne pas la voir. D'accord? Par contre, la prééclampsie, j'ai des moyens, un, de la prévenir, comme je l'ai dit, de la dépister légèrement et de la traiter quand je fais le diagnostic. D'accord? Et donc, la mortalité qui va survenir à cause de l'HRP, de l'éclampsie, de l'ACIVD, de l'insuline vraiment, tout ça, c'est évitable parce que j'aurais pu intervenir avant.

D'accord? La même chose pour l'hémorragie de la délivrance. Il y a beaucoup de problèmes qui sont évitables. L'hémorragie de la délivrance, les étiologies, les causes, les facteurs de risque.

Le macrosomie, je mets l'air. De toute façon, il y a déjà des problèmes de l'hémostase non corrigés, des anémies sévères, des ruptures utérines. Est-ce que ça, ce n'est pas évitable? Le macrosomie, c'est évitable ou pas? Oui, c'est évitable parce que je dois dépister le diabète gestationnel.

C'est un devoir. Première consultation. Donc, je dois dépister.

Si je le dépiste, je peux le traiter. Je fais un bon suivi de ma CPN. Là aussi, je peux diagnostiquer.

Je peux veiller à ce qu'il n'y ait pas de la macrosomie associée. Je vais la prendre en charge dans un centre qui est quand même avec un bloc opérateur à côté si j'accepte la voix basse ou bien je vais programmer la césarienne s'il le faut. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La rupture utérine.

La rupture utérine, heureusement, dernièrement, on ne la voit plus autant qu'avant. C'est catastrophique. C'est une patiente, par exemple, qui a une présentation transverse et que personne n'a vu ça parce que soit elle n'est pas venue à un centre, soit elle est venue et on n'a pas fait notre travail correctement parce que la sage-femme a fait un touché.

Bon, il s'est dit que peut-être c'est une céphalite. Et à qui on n'a pas dit que, attention, si vous rentrez en travail, vous devez aller immédiatement à l'hôpital. Et qui va essayer d'accoucher à la maison ou de tarder pour arriver à la maison d'accouchement.

Et là, elle va faire sa rupture utérine. Présentation de freins. Soit elle a le frein.

C'est une présentation catastrophique et pourvoyeuse de rupture utérine parce qu'il y a un enclavement du frein et le diamètre qui se met dans le détroit est très large. D'accord? Donc, aide le frein. Qui va le diagnostiquer? Le premier touché vaginal qui a été fait à l'admission lors du travail, par exemple.

Et donc, je dois diagnostiquer le frein pour ne pas laisser évoluer le travail, etc., etc. Donc, c'est ça une cause ou plutôt des étiologies évitables. Et bien évidemment, ce qui est aussi évitable, c'est ce qu'on va exprimer ici comme étant un indicateur de qualité du système de santé d'un pays et pas uniquement du système santé, mais aussi de l'évolution d'un pays.

Le développement. Merci. C'est un indicateur du développement général d'un pays.

D'accord? Alors, le deuxième point, c'est l'accessibilité aux soins. Est-ce que c'est juste un problème du système de santé? Il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de sages-femmes, il n'y a pas assez de médicaments. Au soin.

C'est l'accessibilité aux soins. Et ça, vous l'avez vu médiatisé, mais ça, on le vit tous les jours, pas tous les jours, toutes les saisons de neige ici dans la région de Marrakech. c'est l'enclavement des patientes dans les montagnes.

Dès qu'il y a de la neige, eh bien, les chevins sont fermés. Et les femmes, quand elles rentrent au travail, on ne peut pas les ramener vers les maisons d'accouchement ou vers les hôpitaux. Et là, il y a le risque de la rupture utérine, de la mort fatale et de la mort maternelle, justement.

Et ça, les gens se sont rendus compte de ça au moment du séisme. Vous avez vu, ce sont des rues qui sont complètement effondrées au moment du séisme. Ce sont des routes vraiment très périphériques qui sont bouchées dans la saison des neiges ou dans la saison des pluies, par exemple.

D'accord ? Et toute cette population, et vous avez compris qu'il y en a pas mal, ces petits patelins dans les montagnes, il y a une centaine, je ne sais pas plus, de villages qui sont enclavés. Et ça, c'est dramatique dans un pays qui prétend être développé ou qui a des centres comme Casablanca, comme Rabat, comme Marrakech, avec tout le développement économique, toutes sortes de choses comme ça, parce qu'un pays, ce n'est pas que les grandes villes. Quand on compte la mortalité maternelle, on compte tous les pays.

Et même si dans les grandes villes, la mortalité est faible, dans les petits patelins, dans les petites villes, c'est dramatique. D'accord ? Le niveau d'éducation des patientes et des couples par rapport à l'importance de la consultation prénatale. Et ça, les gens apprennent ça dans les écoles.

C'est qu'il y a des situations médicales dans lesquelles il faut se présenter aux soins médicaux rapidement ou même de façon préventive. La logique du dépistage, puisqu'on a expliqué la consultation prénatale, il y a une logique du dépistage. On n'attend pas d'être malade.

Tu dis, mais moi, je vais bien. Je suis enceinte. Oui, mais je ne suis pas malade.

Je suis bien. Donc, je ne vais pas aller consulter. Alors qu'elle est en train de développer sa prééclampsie doucement.

Elle va faire sa première protéinurie à 24 semaines. Et puis à 30 semaines, c'est la bombe à retardement. C'est ce qu'on appelle ça dans les salles d'accouchement quand on a une prééclampsie sévère.

On dit que c'est une bombe à retardement parce qu'elle peut nous faire rapidement une mort fatale, elle peut nous faire rapidement un HRP, même si elle est hospitalisée. Et on en a vu. Prééclampsie, hospitalisée, tranquille, sous traitement, à un moment donné, ils vont la descendre en extrême urgence parce qu'elle a mal, parce qu'elle saigne et parce qu'il y a un HRP.

Donc, vous avez compris. À côté de ça, il y a le niveau économique. Cette femme qui habite, on ne va pas aller dans les montagnes, on va dire qu'elle habite Chichawa, qu'elle habite Tahinau.

Ce sont des petites villes. C'est urbain, soi-disant. Quand il n'y a pas de spécialistes dans ces zones-là, ils n'ont pas le moyen pour se payer le transport et venir à Marrakech.

Ils n'ont pas le moyen pour se payer un bilan, par exemple. D'accord? Ça, c'est le niveau socio-économique de tout le pays qui fait que ça va retentir sur cet index, cet indice qui est l'avantage des maternelles. Catherine, c'est le message que je veux que vous reteniez.

La mortalité maternelle est un indicateur. Maternelle est néonatale. Elle vend toujours de pair.

C'est un indicateur de l'évolution de la qualité du système de santé, c'est sûr, mais aussi du niveau de développement socio-économique d'un pays. D'accord? C'est pour ça qu'on va voir

qu'il va y avoir des programmes, des stratégies pour arriver à diminuer la mortalité maternelle parce que toutes les instances internationales qui, comme l'OMS, comme l'ONU, comme l'UNICEF, qui défendent justement les droits et le bien-être des humains, on va dire, entre parenthèses, et qui peuvent donner des fonds pour aider un pays à améliorer un certain nombre de paramètres, ils exigent qu'au moins vous faites un effort pour diminuer votre mortalité. On va vous aider cette année, l'année prochaine, l'année suivante, mais s'il n'y a aucun résultat et la mortalité maternelle néonatale continue à rester élevée, ça veut dire que vous ne faites pas assez d'efforts pour que ça s'améliore.

Vous avez compris? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une idée sur ça. Donc la définition, elle est précise puisque la mortalité maternelle, c'est le décès d'une femme qui survient au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentels ni fortuits. Donc c'est tous les décès qui vont survenir dans un délai de 42 jours.

Ça vous rappelle quoi, un délai de 42 jours? Oui, c'est l'essuie-de-couche et dans le jargon culturel marocain, elle est déterminée, aggravée par la grossesse. C'est dans la culture ancienne ancestrale qui nous dit qu'elle doit bien manger, qu'elle ne doit pas aller dans le froid, qu'elle ne doit pas aller visiter les gens, etc. Parce que ça, c'est réel.

Parce que ça, c'était des constatations. Une femme qui tombe malade dans les 40 jours du postpartum, c'est grave. Parce qu'elle n'est pas encore rétablie complètement et elle rentre dans une catégorie particulière de risque de mortalité maternelle.

Donc les conseils des grands-mamans, ce n'est pas toujours n'importe quoi. C'est basé sur une culture ancestrale, sur de la médecine traditionnelle ancienne qui est très importante pour la femme enceinte ou une fille. Il y a aussi la mort maternelle tardive, d'accord? C'est la mort d'une femme pour cause obstétrique directe ou indirecte, mais plus ou au-delà des 42 jours après la fin de la grossesse, mais au moins à moins d'un an après.

Alors les 42, c'est un chiffre de l'OMS et l'OMS, elle travaille par statistique. C'est-à-dire qu'elle va donner un chiffre qui est statistiquement significatif à travers un ensemble d'études qui ont été faites et on va se mettre d'accord sur quelque chose. Donc il s'est avéré que c'est une période dans laquelle on voit la mortalité liée aux problèmes de la grossesse.

C'est qu'au-delà de cette période, il y a moins de risques, si vous voulez. C'est-à-dire 40 ou 42, tu me dis, pourquoi c'est 42 exactement? C'est un chiffre statistique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une moyenne, ils ont calculé sur la base d'énormément de données statistiques publiées par le monde entier pour se mettre d'accord sur cette date. C'est très fréquent en médecine.

Et des fois, vous allez trouver des intervalles de quelque chose. Ce n'est pas toujours significatif à un chiffre ou à 0, quelque chose, mais on vous donne quand même un chiffre. Par exemple, l'ICMI, 0,92.

Il faut être inférieur à 0,92 pour dire que vous n'avez pas de diabète gestationnel, que entre 0,92 et 0,98, chez l'ICMI, vous êtes en diabète. Au-delà, vous êtes dans un diabète type 1, non diagnostiqué. C'est une question de chiffre statistique, c'est-à-dire l'ensemble des études qui ont été faites, nous avons compris que la moyenne, c'est ça.

Et on s'est mis d'accord sur ça. Alors, même si parfois c'est dit que les décès tardifs sont liés à la grossesse à cause d'une complication tardive, par exemple, quand on a une insuffisance rénale à cause de la pré-eclampsie, jusqu'à plus de 42 jours, elle est décédée, on va appeler ça mortalité tardive, mais elle se bouelle, le taux de mortalité maternelle, par exemple. Elle avait un AVC secondaire à sa pré-eclampsie aussi, ça a induit une mortalité au-delà de 42 jours dans l'année, mais on ne va pas la compter.

C'est-à-dire, c'est juste pour vous dire que ce qui est comptabilisé comme taux de mortalité, c'est dans la période des 42 jours. Alors, pour le taux de mortalité, le taux de mortalité représente le risque associé à chaque grossesse, ou ce qu'on appelle le risque obstétrical, c'est-à-dire le nombre de décès maternels survenant pendant une année donnée pour 100 000 naissances vivantes, d'accord, pendant la même période. Et donc, le chiffre qui se donne, c'est en chiffre de décès maternel par an par 100 000 naissances vivantes, d'accord.

Alors, naissances vivantes, c'est toutes les naissances d'enfants vivants, c'est l'expulsion, l'extraction complète du corps de la mère d'un produit de conception qui, après la séparation, va respirer, va devenir normal, bien évidemment, on élimine de ça tout ce qui est mort fatale, tout ce qui est fausse couche, tout ce qui est avortement. Et puis, pour le Maroc, il y a beaucoup de chiffres, bon, mais qui représentent tous les risques possibles qu'on court une femme au cours de la grossesse, pour savoir que la grossesse, c'est vrai que c'est physiologique, mais c'est quand même, il y a beaucoup de risques derrière, donc il faut que ce soit bien suivi pour que la maternité soit sans risque, comme on dit, d'accord. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'à peu près 40% peuvent présenter des problèmes de santé qui sont imputables à la grossesse, que le risque d'éclampsie est aussi donc important, et que, bon, c'est un chiffre un peu quand même aggravant, qu'on croit que deux femmes meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement par an, là pour dire dans tout le pays, puisque le taux de mortalité, c'est lié à 100 000 habitants, et vous pouvez multiplier ça sur la totalité de la population.

Il y a aussi un risque qui peut être calculé, qui est le risque de décès maternel sur la durée de vie, c'est-à-dire la probabilité qu'une femme décède un jour d'une cause liée à la grossesse ou à l'accouchement, et là ça peut aller de 1 à 4900 pour les pays développés, alors que dans les pays moins développés, ça peut être 1 sur 180 jusqu'à 1 sur 54 pour certains pays, vous voyez que c'est énorme, c'est-à-dire au cours de la vie d'une femme, elle a un risque sur 54 de mourir au cours d'une grossesse, peut-être la première, la deuxième, la troisième. Dans les pays les moins développés dans ce domaine-là, sinon ça peut aller à 1 sur 4000 ou 5000, c'est un peu logique. Si c'est une carte pour localiser le Maroc comme étant un pays où nous avons encore de

la mortalité maternelle, puisque on est encore par là, d'accord, et il y a certains pays où la mortalité maternelle est vraiment très réduite, il y a même des pays où il y a zéro mortalité maternelle, c'est-à-dire que le système de santé est tellement bien designé qu'on ne rate pas ce qui est évitable.

Et même si l'incident arrive, on a toutes les équipes et les moyens médicaux et technologiques et humains pour gérer la situation critique, d'accord. Et ça, bien évidemment, c'est un pays développé, c'est-à-dire que les gens s'assoient, réfléchissent, mettent des procédures, une procédure du circuit de la patiente, comment la consultation se fait, quels sont les bilans à faire, puis quand elle est à l'hôpital, à l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut faire, la surveillance, etc. Tout est écrit et tout le monde fait la même chose.

L'évolution de la mortalité au Maroc, regardez, depuis les années 90, on était très haut là. Et là, on s'améliore. Les derniers chiffres, j'ai cherché s'il y a des nouveaux chiffres, mais les derniers chiffres annoncés par le ministère, c'est les 75 par 100 000 par an, par 100 000 accouchements, qui étaient en 2015, en espérant que dans les nouvelles statistiques, on ait une amélioration encore plus intéressante.

Ici, pour dire que quand même, on reste loin de nos confrères, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, vous voyez, qui sont mieux que nous par rapport à la mortalité maternelle. Et cette différence-là, au début des années 90, qui a entamé la réflexion et l'obligation pour aller améliorer ça. Alors, si on veut être objectif pour les causes, c'est très simple.

Il y a des difficultés d'accès aux soins, disparité entre milieu et région, urbain, rural, nord, sud, centre, etc. Insuffisance en ressources humaines, que nous vivons toujours. Accueil et qualité de prise en charge des soins obstétricaux et neonato d'urgence, c'est toujours catastrophique.

Pour les principales causes de décès, vous avez remarqué qu'il y a deux choses qui sont les plus importantes. La première, c'est l'hémorragie, donc 33%. Et la pré-éclampsie, 18%.

Les autres sont moins fréquents. Donc, il y a les décès par des causes obstétricales directes, c'est-à-dire au cours du travail, la rupture utérine, l'hémorragie, etc. Ou par intervention ou omission, c'est ce qui est dangereux et ce qui est grave, c'est-à-dire que la personne n'a pas reçu des soins de qualité.

Il y a des choses qui ont manqué, soit par manque de matériel, par absence de spécialistes sur place, par problème de transport. Vous devez savoir que dans notre pays, il y a encore des situations dans lesquelles le couple doit payer une ambulance, doit payer l'essence de l'ambulance publique pour le transporter vers un hôpital. Donc, c'est vraiment encore dramatique.

Et si vous passez dans notre service, vous allez voir qu'on reçoit énormément d'accouchements normaux, ce qui est aberrant pour un hôpital de troisième niveau. Un hôpital de troisième niveau, comme notre maternité, devrait faire presque 10% d'accouchements normaux, et le reste, tous

les grossesses à risque ou les grossesses compliquées. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre en œuvre tout notre potentiel pour traiter correctement ces femmes à risque.

Mais quand on est dilué par le nombre d'accouchements normaux, des fois on a des accouchements à risque qui vont passer inaperçus parce que le rythme est très important, et ça c'est dangereux. En plus, il y a une consommation de temps, d'effectifs, d'énergie, des équipes, et aussi du consommable. Et tout ça, pourquoi? Parce que dans la région, on n'a pas d'hôpitaux provinciaux qui marchent bien, ni d'hôpitaux régionaux.

Et ça, c'est encore un problème politique, un problème logistique, et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à en sortir. Enfin, je le sais, mais ça fait de la peine toujours. Donc, les causes indirectes, ça peut être une maladie préexistante ou une infection apparue au cours de la grossesse et qui va engendrer un décès au cours de la grossesse, soit par aggravation de la maladie, par exemple, ou tout simplement par la maladie elle-même.

Donc ça, c'est juste une répétition pour dire que les morts agissent en premier, les troubles hypertensifs en deuxième, il y a l'infection, elle est distancée au cours du travail, et puis il y a aussi les problèmes pour les patients qui ont des avortements à risque. Cardiopathie et anémie restent parmi les causes les plus fréquentes des décès indirects. Ce tableau, c'est juste pour vous parler de ça, qui sont les mortalités maternelles fortuites ou accidentelles, c'est-à-dire un décès qui survient lors de la grossesse ou dans les suites, mais dont les causes n'ont aucun rapport avec ces décès.

Un accident de la voie publique, par exemple, ça n'a pas de rapport avec la grossesse, mais ça va être comptabilisé comme une mortalité maternelle. Donc, à cause de tout ça, et vu que l'image d'un pays, elle est représentée aussi par cet indice qui est le taux de mortalité maternelle, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, beaucoup de programmes qui ont été enchaînés d'année en année, qui essayent d'améliorer la mortalité maternelle. À mon avis, ça a boosté un petit peu, c'est vrai que la courbe a baissé, mais on est loin d'aboutir aux résultats estimés.

Vous n'êtes pas obligés de suivre ça, mais si vous voulez lire pour votre information, à chaque fois le ministère de la Santé, soit de façon quinquennale, c'est-à-dire tous les cinq ans, va faire une stratégie, il va évaluer ce qui s'est passé avant, puis il va mettre des programmes pour améliorer, pour arriver à des objectifs qu'il doit établir, et ces objectifs en général suivent ce qui est recommandé par l'OMS et par les instances internationales, comme ce que vous trouvez ici essentiellement, lutter contre l'inégalité dans l'accès aux services des soins, la couverture sanitaire, c'est ce qui est maintenant en train d'être fait, ça c'est les objectifs vers 2030, d'accord, assurer la couverture et les soins complets maternels et néonatales, lutter contre les causes de mortalité directe, etc. Tout ça c'est joli, mais il faut l'appliquer. Vous n'êtes pas obligés de prendre tout ça, d'accord, la gouvernance.

Alors, c'est une relation assez intéressante par rapport à ce qu'on appelle le taux de recrutement

à la CPN et le taux d'accouchement en milieu surveillé, ça c'est un taux, un chiffre aussi important et qui reflète est-ce que notre système santé fonctionne ou pas, c'est-à-dire qu'on devrait au maximum recruter les patients pour faire de la CPN et c'est ce qui est en bleu et on voit quand même depuis les années 90 que maintenant il y a un recrutement qui s'améliore mais qui n'est pas encore à 100%, d'accord, il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de CPN ou qui la font de façon interrompue, etc. Et aussi cet indicateur d'accouchement en taux médicalement surveillé, il est aussi loin d'être à 100%. Vous allez me dire qu'actuellement la tendance dans les autres pays aussi c'est de faire des accouchements à domicile, des accouchements dans le naturel, etc.

C'est possible, oui, mais ce sont des pays qui ont passé cette cape, c'est-à-dire ils sont arrivés au 100% de couverture médicale mais que les soins pour être humanisés et pour que la patiente ne soit pas dans un hôpital qui est le stress de la médicalisation ou de la sur-médicalisation, la voie veineuse, la période urale systématique, la perfusion d'ocytocine systématique, ils sont revenus pour humaniser l'accouchement et pour favoriser tout ce qui est naturel. Parce qu'une femme quand elle va bien, quand tout va bien dans la consultation prénatale, elle peut accoucher naturellement mais elle va être surveillée par un agent médical qui est représenté par la sage-femme qui doit être là obligatoirement et un moyen d'évacuation qui doit être là obligatoirement. C'est-à-dire qu'on démarre un accouchement par voie basse mais entre-temps on peut toujours avoir quelque chose qui survient et donc on devrait être capable de transporter cette patiente au plus vite, de façon césarienne, rapidement dans un centre à côté et ça, ça doit être organisé.

Et donc il y a des pays qui arrivent à faire ça maintenant et ça permet d'avoir des accouchements dans le naturel. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à faire d'ACPN pour tout le monde et donc si on leur dit vous accouchez à domicile, c'est la catastrophe. Donc on va revenir à des taux de mortalité encore plus élevés et on n'a pas encore de couverture à 100% pour les accouchements dans les milieux surveillés.

Naissance attendue et c'est la même chose. En fait, on est capable de, par rapport à une population générale et par rapport au pourcentage de femmes et le pourcentage de femmes mariées dans une population, de calculer les naissances attendues par rapport au taux de croissance lienne. Donc si on voit, ça c'est les estimations des accouchements attendus, on voit que c'est largement plus haut que les accouchements qui se font dans les milieux surveillés.

Et donc plus on a cette différence, plus ici il y a le risque de mortalité maternelle et néonatale pour ces patientes qui accouchent quelque part dans la nature. Le taux de césarienne aussi est un taux qui reflète la qualité de la prise en charge au cours de la grossesse, parce que si on fait trop peu de césarienne, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est-à-dire quel serait son retentissement sur le risque de mortalité? Augmenter. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez de césarienne prophylactique.

On ne diagnostique pas des choses qui nécessitent de faire une césarienne avant de trouver la

patiente au travail. Quand on trouve la patiente au travail, il y a des revenus et des dépenses. C'est bon, mais le risque était là, elle aurait pu passer de l'autre côté et faire une complication grave.

Et donc l'OMS, elle a un taux de référence de césarienne, normalement, qui devrait être fait, et qui devrait être aux alentours de 15% dans un hôpital niveau 2, on va dire, pas niveau 3. Niveau 3, c'est clair qu'on reçoit des formes compliquées. Donc on a un taux de césarienne qui est élevé, ça se comprend. Mais maintenant, la façon dont on fonctionne maintenant, on fonctionne comme à niveau 2. Donc on devrait être aux alentours de 15% normalement.

Et donc les villes ou les hôpitaux qui ne font pas ce taux entre 10 et 15%, soit ça veut dire qu'il y a un risque de mortalité, parce qu'ils ne font pas assez de césariennes programmées, soit qu'il faut des césariennes de convenance. Et c'est le cas dans le secteur privé marocain aussi, mais dans le monde aussi, le Brésil, l'Argentine et tout ça, tout le monde accouche par césarienne, personne n'accouche plus. Quel est le risque quand on fait trop de césariennes? Je pense que c'est la mortalité.

Mais la morbidité va être là, parce qu'une césarienne, c'est une anesthésie, avec les risques de complications d'anesthésie. C'est une intervention chirurgicale. On sait qu'en césarienne, il y a des pertes sanguines supérieures à la gauche par voie basse.

Quand on fait 500 cc par voie basse, on va faire un litre de déperdition. Et donc, si c'est une patiente anémique ou cardiaque ou autre chose, elle va décompenser. D'accord? Et aussi, on va créer beaucoup de quoi? D'utérus cicatriciel, c'est-à-dire la prochaine grossesse va être une grossesse sur utérus cicatriciel.

Le chapitre d'utérus cicatriciel, c'est une grossesse et un accouchement à risque. Et plus le nombre de césariennes chez une patiente augmente, plus on a un risque majeur. Et les mortes de mort en ce moment, je ne sais pas.

Non? Non. Normalement, si on a plusieurs césariennes, on devrait programmer la césarienne suivante pour éviter la rupture. Mais avant même le travail, implantation.

D'accord? Ce sont les implantations anormales du placenta ou les implantations invasives du placenta, le kétémine aussi, le spectre placenta. C'est-à-dire que le placenta va envahir la zone de la cicatrice, ça peut se limiter flumiomètre, lacéreuse, il y a l'invasion de l'AVC ou du rectum ou peu importe. Et donc vous voyez si le taux de césarienne est trop élevé, on va tomber dans le versant pathologique.

Donc la cible actuelle par rapport à la mortalité maternelle, c'est d'aboutir à un chiffre de 36 décès par an par 100 000 naissances à l'horizon de 2030. Donc problème majeur, oui, c'est un indicateur de développement évitable, sachez-le. Donc si vous avez un rôle énorme dans cette histoire, autant que généraliste, et ça je le dis aussi aux généralistes qui sont déjà diplômés et

qui font de la formation continue, vous avez un rôle énorme dans cette histoire parce qu'en général, le généraliste, il est le plus proche de la population.

Ce n'est pas le gynécologue. Le gynécologue, c'est quand il y a un problème, c'est quand on veut opérer, c'est au moment de l'accouchement, mais c'est le généraliste qui devrait faire les suivis du maximum de grossesse. Et donc la clé de la réussite, de tous les problèmes de mortalité maternelle, c'est une bonne CPN, une bonne consultation prénatale.

Chaque consultation a des objectifs. Je dois réfléchir, je dois garder en tête les facteurs de risque, etc. C'est d'accord? Voilà.

Merci beaucoup. Il y a des questions? C'est bon? Ok.